

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas

São Paulo

2026

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é reduzir a taxa de evasão e melhorar a experiência do usuário em clínicas médicas, ao mesmo tempo mantendo o lucro. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se realizar a otimização do overbooking a partir do uso de simulação, modelos probabilísticos e teoria das filas. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1 Introdução

1.1 Contexto

O *overbooking* é uma prática muito utilizada nos setores de aviação e da medicina, onde, para os respectivos setores, uma companhia vende mais passagens do que a capacidade real de assentos em um voo e um hospital agenda mais consultas do que a clínica consegue atender. O principal objetivo dessa prática é garantir que o avião parta lotado, ou que a clínica consiga ocupar todos os horários disponíveis para consultas, com a premissa de que um certo número de passageiros ou pacientes não comparecerão (*no-shows*).

No contexto da medicina em específico, segundo Zeng et al. (2013), a utilização de *overbooking* em serviços de atenção primária pode aumentar a taxa de ausência de pacientes e, para valores críticos do número de pacientes sob responsabilidade do médico (*panel-size*), pode impactar negativamente o desempenho financeiro da clínica ou hospital.

1.2 Justificativa

1.2.1 Relevância acadêmica

1.2.2 Relevância prática

A otimização do *overbooking* pode contribuir na redução do tempo de espera para o atendimento e na redução de ausência dos pacientes, melhorando a eficiência operacional de clínicas e hospitais.

1.2.3 Lacuna identificada

Ainda há limitações na compreensão dos impactos do *overbooking* em ambientes de clínicas e hospitais, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre eficiência, qualidade do atendimento e experiência do paciente. Estudar o *overbooking* e buscar um número otimizado de agendamentos pode gerar tanto desafios quanto oportunidades.

Um dos fatores principais nesse contexto é a experiência do paciente, já que ela está diretamente relacionada com a possibilidade de retorno e fidelização, especialmente em tratamentos longos ou contínuos, como a psiquiatria. Então, melhorar essa experiência pode contribuir com um aumento de receita, além de recomendações vindas de outros pacientes.

Ademais, a compreensão do *overbooking* também permite a avaliação de eficiência do médico. Isso é algo relevante para a clínica, já que possibilita uma melhor análise de seus

profissionais. Nos casos em que o médico é o dono do próprio consultório, a análise do *overbooking*, em conjunto com o tempo médio de atendimento, age como um feedback próprio de sua eficiência, permitindo uma visão mais clara do desempenho e potencial do consultório como negócio.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Otimizar o uso de *overbooking* em consultas médicas a partir da utilização de um modelo treinado para a predição de ausências nas consultas médicas, e teoria das filas para realizar simulações aplicando o modelo, com o objetivo de reduzir a taxa de evasão dos pacientes e melhorar sua experiência durante o atendimento.

1.3.2 Objetivos específicos

Para o desenvolvimentimento do projeto, é necessário compreender a linha de processos envolvida em um diagnóstico, identificando cada uma das etapas desde o início do atendimento até a entrega do diagnóstico. Esse mapeamento torna possível a compreensão do funcionamento do processo, tornando viável o reconhecimento de pontos críticos, atrasos e falhas capazes de comprometer o tempo de diagnóstico. Essa análise torna plausível a identificação do momento onde ocorre o principal gargalo do sistema, ou seja, a sessão do processo onde existe o maior tempo de espera. Este gargalo pode estar presente em diversos momentos do processo, como na fila de espera para o atendimento inicial, no intervalo entre a realização dos exames e a devolução do diagnóstico ou em outras fases intermediárias.

Com isso, será construído um modelo de processos capaz de representar o funcionamento dos mesmos. Esse modelo será capaz de testar múltiplos cenários, tornando possível a avaliação de como mudanças na organização do atendimento, na distribuição de recursos ou no fluxo de pacientes podem impactar o tempo de espera de devoluções. Depois da criação do modelo, simulações serão realizadas com o intuito de observar como o processo se comporta em diferentes condições para comparar cenários e identificar alternativas mais eficientes. Por último, em função dos resultados obtidos nas simulações, será desenvolvido um algoritmo de otimização com a finalidade de propor melhorias capazes de reduzir gargalos e tornar o processo de diagnóstico mais rápido.

2 Revisão bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida a partir da consulta a diferentes bases de dados acadêmicas e científicas, com o objetivo de identificar trabalhos relevantes sobre o tema. Dentre as bases, foram consultadas: Google Scholar, Core, Taylor & Francis Online, ProQuest e Semantic Scholar, onde foram considerados trabalhos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português e inglês, incluindo artigos científicos e estudos de caso.

Em cada base, foi utilizado um conjunto de strings de busca, onde, dado os resultados, foram selecionados artigos e estudos condizentes com a proposta deste trabalho. Segue abaixo uma tabela com os resultados obtidos, com base na string de busca e plataforma:

Tabela 1 – Resultados de busca nas bases de artigos

Base	String de busca	Resultados da busca	Artigos Seleccionados
Semantic Scholar	overbooking AND (queue OR simulation) AND health	849	6
Google Scholar	("teoria das filas"OR "modelo de filas") AND ("medicina"OR "saúde"OR "clínica") AND ("simulação"OR "mobile")	210	5
Google Scholar	("teoria das filas"OR "modelo de filas") AND ("restaurante"OR "fast food"OR "fast-food") AND ("simulação"OR "mobile")	47	7

A partir dos resultados, e da seleção dos artigos, foi aplicado a técnica de "funil", no qual realiza-se o filtro dos artigos mais relevantes, e é definido os artigos principais de referência.

2.3 Fundamentos

2.3.1 Overbooking

O *overbooking* é a venda de um número de produtos ou serviços em maior número que o estoque atual ou a capacidade de serviço, sendo aplicado principalmente nas áreas da saúde e da aviação. O *overbooking* surgiu como uma maneira de compensar o lucro perdido

por conta de clientes que não comparecem ou cancelam o serviço (Denominado como *no-shows*), utilizando todo o estoque ou capacidade do serviço disponível para balancear a eficiência operacional e a qualidade do serviço. No contexto clínico, o principal *trade-off* do *overbooking* é entre a eficiência operacional e a qualidade do serviço: segundo Zeng et al. (2013), o maior uso da equipe médica derivado do *overbooking* pode trazer benefícios como maior lucro e redução do atraso para conseguir uma consulta (*appointment-delay*). Porém, essa prática aumenta o tempo de espera no consultório para ser atendido (*office-delay*) e pode até reduzir o lucro da clínica para valores críticos de *panel-size*.

2.3.2 Métricas

Para avaliar o modelo, serão utilizadas métricas baseadas na qualidade e eficiência de serviço, levando em consideração o *overbooking* e a estabilidade da clínica. A partir disso, escolhemos trabalhar com o tempo médio de *office-delay*, o tempo do *appointment-delay* e a taxa de *no-shows*. Também serão utilizadas outras métricas como a taxa de utilização de recursos para garantir estabilidade.

2.3.3 Rede Neural Recorrente

Uma Rede Neural Recorrente (Referenciada pela sigla em inglês RNN – *Recurrent Neural Network*) é uma rede neural profunda, com diversas camadas escondidas, treinada a partir de dados sequenciais ou séries temporais, com o objetivo de criar um modelo de aprendizado de máquina para realizar previsões. O principal diferencial das RNNs está em sua capacidade de utilizar informações de entradas prévias para influenciar o valor atual de entradas e saídas. Para uma determinada entrada, a RNN mantém um estado oculto, responsável por acompanhar o contexto e agir como uma memória que armazena informações das entradas anteriores, processando a entrada atual junto com o estado oculto da etapa anterior em cada etapa, dando uma capacidade de "lembrar" dados anteriores, influenciando o valor da saída atual. No contexto clínico, utilizaremos a RNN para prever a probabilidade de *no-shows* e ajustar o nível de *overbooking* em função do modelo.

2.4 Trabalhos relacionados

Com base no nosso problema, e na nossa proposta de solução, encontramos 3 artigos relevantes, com problemas e soluções semelhantes.

2.4.1 Trabalho 1: Appointment Capacity Planning With Overbooking for Outpatient Clinics With Patient No-Shows

Este trabalho abordou o problema de aderência dos pacientes, juntamente com a grande lista de espera em clínicas. Nele, utiliza-se provas matemáticas para comprovar a eficácia do modelo, enquanto no nosso trabalho utilizaremos ferramentas diferentes e olhando para o *overbooking* como causa do problema.

Além disso, é possível observar que a falta de métricas como o tempo de fila e o tempo de atendimento causa uma limitação na coleta de resultados, ou seja, com essa coleta, teremos mais visibilidade em relação à experiência do paciente.

2.4.2 Trabalho 2: Health care overbooking cost minimization model

Esse trabalho aborda a resolução do *overbooking* no sistema de saúde, otimizando valores a partir de um modelo, de forma que o número escolhido de *overbooking* seja o melhor, otimizando sua eficiência. Dado os resultados, conclui-se que temos o prejuízo pela falta de organização, e não pelo *overbooking* em si. Além disso, há problemas como a complexidade, necessidade de dados e o custo financeiro para a implementação do estudo. Outra dificuldade encontrada no trabalho foi a generalização do modelo, na qual foi voltada para uma rede de hospitais da Arábia Saudita, além de haver certas informações que foram ignoradas, como idade, gênero, condição de saúde, e geolocalização.

2.4.3 Comparação

Notamos que ambos os trabalhos tratam do mesmo assunto, que são problemas em clínicas médicas. Porém vemos abordagens diferentes e resultados diferentes, onde ambos podem ser utilizados como base para melhor nosso trabalho, gerando uma combinação de conceitos matemáticos e estatísticos do primeiro artigo, junto com a ideia de criar um modelo e "organizar" o *overbooking* eventualmente impactando no aumento do lucro e na melhor experiência para o paciente. Ou seja, nosso trabalho olha para ambos e complementa usando RNN para prever *no-shows*.

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Este trabalho
Objetivo	O problema de aderência dos pacientes, juntamente com a grande lista de espera em clínicas	Resolução do overbooking no sistema de saúde, otimizando valores	Organização do overbooking eventualmente impactando no aumento do lucro e na melhor experiência para o paciente
Tecnologia	Utiliza-se provas matemáticas para comprovar a eficácia do modelo	Modelo para definir o número escolhido de overbooking seja o melhor, otimizando sua eficiência	Uso de RNN para prever no-shows
Validação	Provas matemáticas para comprovar a eficácia do modelo	Dado os resultados, conclui-se que temos o prejuízo pela falta de organização, e não pelo overbooking em si	Combinação de conceitos matemáticos e estatísticos
Limitação	Falta de métricas como o tempo de fila e o tempo de atendimento causa uma limitação na coleta de resultados	Complexidade, necessidade de dados, custo financeiro, dificuldade de generalização(rede de hospitais da Arábia Saudita) e ausência de informações como idade, gênero, condição de saúde e geolocalização	—

Fonte: Elaborado pelo autor

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **CrITÉrios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

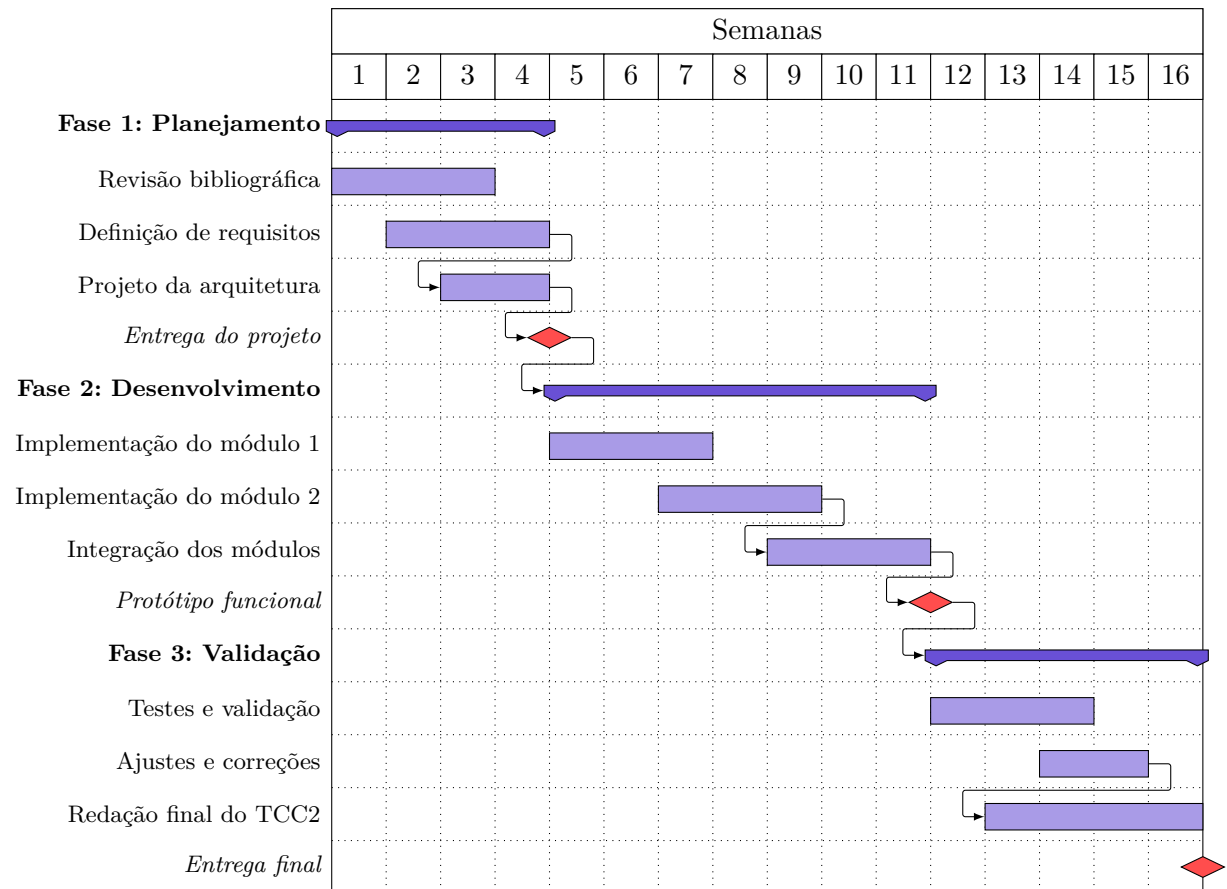
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.